# Carcinome Basocellulaire

Niveau : DES dermatologie
Genere le 15 April 2026

*Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG*

# Carcinome Basocellulaire

*Cours de niveau DES dermatologie — Généré par DermatoRAG*

---

# Diagnostic

## Diagnostic du Carcinome Basocellulaire

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche méthodique combinant l'examen clinique, la dermatoscopie, l'histopathologie et, dans certains cas spécifiques, l'imagerie. L'objectif est d'établir un diagnostic de certitude, de caractériser la tumeur et d'évaluer son potentiel évolutif afin d'orienter la stratégie thérapeutique et la surveillance. Les recommandations pour la pratique clinique, telles que celles de l'ANAES (2004) et de la HAS, INCa, SFD (2009), constituent des références fondamentales pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces lésions (Dermatologie, 2022).

### *1. Diagnostic Clinique et Dermatoscopique*

Le diagnostic clinique du CBC est souvent évoqué devant des lésions cutanées présentant des caractéristiques morphologiques spécifiques, particulièrement sur les zones photo-exposées. Le CBC est la forme la plus courante de cancer cutané et son incidence est en augmentation rapide à l'échelle mondiale (Arits et al., 2013).

#### 1.1. Aspects Cliniques Évocateurs

Les formes cliniques du CBC sont variées, mais certaines caractéristiques sont hautement suggestives :

- **Carcinome basocellulaire nodulaire** : Il se présente typiquement comme une papule arrondie, translucide, perlée, souvent associée à des télangiectasies en surface (Dermatologie, 2022 - Cas clinique 20). Cette forme est la plus fréquente (Arits et al., 2013).
- **Carcinome basocellulaire superficiel (ou pagétoïde)** : Il apparaît comme une plaque érythémateuse, squameuse, souvent avec un fin ourlet perlé en périphérie, pouvant ressembler à un eczéma ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022 - Source 5, Fig. 20.8; Arits et al., 2013). Un tiers des CBC sont de ce sous-type et se localisent fréquemment sur le tronc (Arits et al., 2013).
- **Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (ou morphéiforme)** : Cette forme se caractérise par une plaque indurée, atrophique, blanchâtre ou jaunâtre, aux limites imprécises, évoquant une cicatrice ou une morphée (Dermatologie, 2022 - Fig. 20.9). Elle est considérée comme une forme mal limitée et infiltrante, associée à un stroma dense et fibreux à l'histologie, et représente un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022 - Source 5, Encadré 20.3).
- **Carcinome basocellulaire ulcéro-végétant** : Il s'agit d'une lésion ulcérée, souvent croûteuse, avec des bords surélevés et perlés (Dermatologie, 2022 - Fig. 20.10).
- **Carcinome basocellulaire pigmenté (ou "tatoué")** : Il présente des caractéristiques cliniques des formes précédentes mais avec une pigmentation

variable, pouvant rendre le diagnostic différentiel avec un mélanome plus complexe (Dermatologie, 2022 - Source 5).

La localisation de la lésion est un élément pronostique important. Les CBC situés à l'extrémité céphalique, notamment sur le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérés comme des facteurs de mauvais pronostic en raison de leur potentiel invasif local et de la complexité de l'exérèse chirurgicale dans ces régions (Dermatologie, 2022 - Encadré 20.3; Sartore et al., 2011). Un diamètre élevé, en particulier supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est également un critère de risque (Dermatologie, 2022 - Encadré 20.3).

#### 1.2. Apport de la Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil précieux qui complète l'examen clinique en permettant de visualiser des structures non visibles à l'œil nu. Pour les CBC "easy-to-treat" (faciles à traiter), le diagnostic est souvent basé sur les caractéristiques clinico-dermoscopiques (Peris et al., 2019). Les critères dermatoscopiques typiques du CBC incluent la présence de télangiectasies arborisantes, de zones bleues-grises ovoïdes, de multiples érosions, de nids ovoides bleus-gris, de structures en feuille d'érable et de rayons de roue. La présence de pigmentation peut indiquer un CBC pigmenté.

## *2. Diagnostic Différentiel*

Le diagnostic différentiel du CBC est large et doit être envisagé devant toute lésion cutanée suspecte, en particulier sur les zones photo-exposées.

#### 2.1. Autres Tumeurs Cutanées

- **Carcinome épidermoïde cutané (CEC)** : Le CBC doit être distingué du CEC, qui partage des facteurs de risque communs liés à l'exposition solaire. Le CEC peut se présenter sous des formes variées, allant de la kératose actinique (lésion précancéreuse) à des lésions ulcéro-végétantes (Dermatologie, 2022 - Source 1).
- **Maladie de Bowen** : Il s'agit d'un carcinome épidermoïde in situ, apparaissant comme une plaque érythémateuse squameuse, pouvant être confondue avec un CBC superficiel (Dermatologie, 2022 - Source 5).
- **Mélanome** : Les CBC pigmentés peuvent être confondus avec des mélanomes, en particulier le mélanome nodulaire ou le mélanome superficiel extensif (Dermatologie, 2022 - Source 5). L'examen dermatoscopique est crucial pour différencier ces entités.
- **Carcinome basosquameux** : Cette entité est un néoplasme cutané à haut risque, souvent sous-reconnu, qui présente des caractéristiques histologiques intermédiaires entre le CBC et le CEC (Costantino et al., 2006; Garcia et al., 2009; Tan et al., 2017). Il est associé à des facteurs pronostiques influençant la récidive (Martin et al., 2000) et peut avoir un impact significatif sur la progression de la maladie, notamment au niveau de la tête et du cou (Wermker et al., 2015). Sa reconnaissance est essentielle en

raison de son comportement plus agressif que le CBC pur.

• **Autres tumeurs cutanées** : Kératose actinique, kératose séborrhéique, naevus, etc. (Dermatologie, 2022 - Source 1).

#### 2.2. Autres Dermatoses

Le CBC superficiel peut être confondu avec des dermatoses inflammatoires ou infectieuses, telles que le psoriasis ou une dermatophytie, en raison de leur aspect érythémato-squameux (Dermatologie, 2022 - Source 5).

## *3. Diagnostic de Certitude et Anatomopathologie*

Le diagnostic de certitude du CBC repose impérativement sur l'examen anatomopathologique de la lésion.

#### 3.1. Modalités de Prélèvement

• **Exérèse à visée diagnostique** : Devant un aspect clinique et dermatoscopique très évocateur, une exérèse chirurgicale complète de la lésion, avec des marges de sécurité appropriées, peut être réalisée d'emblée. La pièce d'exérèse est ensuite soumise à un examen anatomopathologique pour confirmation diagnostique et caractérisation histopronostique (Dermatologie, 2022 - Source 5).

• **Biopsie** : Une biopsie est indiquée dans plusieurs situations :

* Lorsque le diagnostic clinique est incertain (

# Bibliographie


• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• nmsc

• squamous

• Arits et al. - 2013 - Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superfici

• Drucker et al. - 2018 - Treatments of Primary Basal Cell Carcinoma of the Skin A Systematic Review and Network Meta-analysi

• Peris et al. - 2019 - Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma European consensus–based interdisciplinary guidelin

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r